

Pr  paration - R  sidanat 2025

Hyperthyro  die - Objectif N  39

1- Les signes   vocateurs d'hyperthyro  die sont :

- A- La polyphagie
- B- Une prise de poids
- C- Le signe de Tabouret positif
- D- Un syndrome polyuro-polydipsique discret
- E- Un prurit

2- Les signes   vocateurs d'hyperthyro  die sont :

- A- Un   r  thisme cardiaque
- B- Un pincement de diff  rentielle de la pression art  rielle
- C- Un   tat anxio-d  pressif
- D- Une tachycardie de repos
- E- Des r  flexes ost  o-tendineux diminu  s

3- L'hyperthyro  die entra  ne :

- A- Une augmentation de la contractilit   myocardique
- B- Une diminution du d  bit cardiaque
- C- Une diminution de la consommation d'oxyg  ne
- D- Un souffle systolique de haut d  bit
- E- Une tachycardie exag  r  e par l'effort

4- Les anomalies biologiques observ  es au cours de l'hyperthyro  die sont :

- A- Une diminution de l'ost  ocalcine s  rique
- B- Une augmentation des enzymes h  patiques
- C- Une augmentation des triglyc  rides
- D- Une leuco-neutrop  nie
- E- Une   l  vation de la calc  mie

5- Les causes iatrog  nes d'hyperthyro  die sont :

- A- L'amiodarone
- B- La corticoth  rapie
- C- Le lugol
- D- Les inhibiteurs de tyrosine kinase
- E- L'interf  ron

- 6- Le bilan de 1  re intention en cas de suspicion d'hyperthyro  die est :**
- A- La TSH + T4 libre
 - B- La TSH + T3 et T4 libres
 - C- La FT4
 - D- La FT3
 - E- La TSH
- 7- L'hyperthyro  die subclinique chez un homme de 70 ans peut   tre    l'origine d' :**
- A- Une TSH frein  e
 - B- Une TSH normale avec FT4   lev  e
 - C- Une TSH basse avec FT4 et FT3 normales
 - D- Une TSH basse, FT4 normale et FT3   lev  e
 - E- Une TSH entre 5 et 10 mUI/L
- 8- L'hyperthyro  die subclinique au long cours a un risque potentiel d'alt  ration :**
- A- Lipidique
 - B- Osseuse
 - C- Hypophysaire
 - D- R  nale
 - E- Cardiaque
- 9- Les complications d'hyperthyro  die non trait  e sont:**
- A- Le diab  te
 - B- La fibrose pulmonaire
 - C- Un acc  s maniaque
 - D- L'insuffisance cardiaque
 - E- Une Paralysie p  riodique hypokali  mique
- 10- Les complications cardiaques de l'hyperthyro  die :**
- A- Sont fr  quentes chez le sujet jeune
 - B- Sont favoris  es par l'existence d'une cardiopathie ant  rieure
 - C- Peuvent r  v  ler l'hyperthyro  die
 - D- Peuvent se traduire par une arythmie compl  te par fibrillation auriculaire
 - E- Peuvent se traduire par une d  compensation d'une insuffisance coronaire
- 11- La crise aigu   thyrotoxique peut se manifester par :**
- A- Une froideur des extr  mit  s
 - B- Des vomissements
 - C- Une psychose
 - D- Des diarrh  es aigu  s
 - E- Une tachycardie sinusale sup  rieure    140/min

12-Les facteurs d  clenchants potentiels de crise aigu   thyrotoxique sont :

- A- Un Accident vasculaire c  r  bral
- B- La phase pr  coce du traitement par iode radioactif
- C- Une chirurgie
- D- L'instauration d'anti-thyro  diens de synth  se
- E- L'administration de produit de contraste iod  

13-Les complications graves de thyrotoxicose qui peuvent engager le pronostic vital sont :

- A- Les cardiomyopathies
- B- L'ophtalmopathie de Basedow compliqu  e
- C- La crise aigu   thyrotoxique
- D- La paralysie p  riodique thyrotoxique hypokali  mique
- E- La myopathie thyrotoxique

14-L'hyperthyro  die peut   tre due   :

- A- Une carence iod  e
- B- Une surcharge iod  e
- C- Une atteinte auto-immune
- D- Une prise d'hormones thyro  diennes
- E- Une prise de s  l  nium

15-Les causes tumorales d'hyperthyro  die sont :

- A- La thyro  dite d'Hashimoto
- B- Le go  tre multinodulaire toxique
- C- La thyro  dite de De-Quervain
- D- La maladie de Basedow
- E- L'ad  nome toxique

16-Devant une hyperthyro  die, les signes en faveur de la maladie de Basedow sont :

- A- Le caract  re vasculaire du go  tre    l'  chographie
- B- La pr  sence de thrill    la palpation du go  tre
- C- Le signe de Von Graefe
- D- Une scintigraphie h  t  rog  ne
- E- La pr  sence d'anticorps anti r  cepteurs de la TSH de type stimulant

17-La maladie de Basedow peut   tre pr  cipit  e par :

- A- Une insuffisance surr  nolienne associ  e
- B- Le stress
- C- Un choc   motionnel
- D- Une constipation
- E- Une corticoth  rapie

18- L'ophtalmopathie basedowienne :

- A- A une origine auto-immune
- B- Est sans relation avec le degr   de thyrotoxicose
- C- Est en relation avec le taux des anticorps anti-r  cepteurs de TSH
- D- Est am  lior  e par les anti-thyro  diens de synth  se
- E- N  cessite un traitement par corticoth  rapie

19- L'ophtalmopathie basedowienne peut   tre aggrav  e par :

- A- Le tabac
- B- Une   l  vation de TSH
- C- Le s  linium
- D- La chirurgie thyro  dienne
- E- Le traitement par iode radioactif

20- Les anticorps anti-r  cepteurs de la TSH :

- A- Doivent   tre recherch  s d  s la d  couverte d'hyperthyro  die au cours de la grossesse
- B- Sont n  cessaires pour le diagnostic positif de maladie de Basedow
- C- Sont utiles lorsque l'arr  t du traitement de maladie de Basedow est envisag  
- D- Ont une sensibilit     lev  e pour la maladie de Basedow
- E- Permettent d'adapter la dose de traitement    la d  couverte d'une maladie de Basedow

21- La thyroglobuline circulante est   lev  e au cours des hyperthyro  dies par :

- A- Thyro  dite de De-Quervain
- B- Goitre multinodulaire toxique
- C- Maladie de Basedow
- D- Thyrotoxicose gestationnel transitoire
- E- Thyrotoxicose factice

22- La thyro  dite d'Hashimoto est caract  ris  e par :

- A- Des anticorps anti-TPO positifs
- B- Une hyperfixation du radiotraceur    la scintigraphie thyro  dienne
- C- Une survenue plus fr  quente chez la femme
- D- Un goitre multi-nodulaire
- E- Une VS   lev  e

23-La thyro  dite de Dequervain est caract  ris  e par :

- A- Une hyperthyro  die d  couverte par une complication cardiaque
- B- Un goitre douloureux
- C- Son caract  re aigu
- D- Une VS acc  l  r  e
- E- Une   volution possible vers une hypothyro  die

24-Les signes de mauvais pronostic de l'orbitopathie basedowienne sont :

- A- Une inocclusion palp  brale
- B- Une asynergie oculo-palp  brale
- C- Paralysie compl  te d'un ou plusieurs muscles
- D- Neuropathie optique
- E- R  traction de la paup  re sup  rieure

25-La scintigraphie thyro  dienne peut montrer une fixation basse au cours d'une hyperthyro  die secondaire    :

- A- La maladie de Basedow
- B- La thyro  dite silencieuse
- C- L'hyperthyro  die iatrog  ne induite par iode
- D- Un Goitre multi-nodulaire toxique
- E- Une thyrotoxicose factice

26-Les anti-thyro  diens de synth  se :

- A- Inhibent la synth  se d'hormones thyro  diennes
- B- Emp  chent la s  cr  tion des hormones thyro  diennes d  j   synth  tis  e
- C- Bloquent la thyrop  roxydase
- D- N  cessitent un d  lai d'action de 24 heures
- E- Inhibent la synth  se de TSH

27-La surveillance d'une hyperthyro  die trait  e m  dicale  ment depuis un mois se fait par :

- A- La FT3
- B- La TSH et FT4
- C- Les anticorps anti-r  cepteur de la TSH
- D- La thyroglobuline
- E- La FT4 seule

28- Les effets ind  sirables les plus fr  quents des antithyro  diens de synth  se sont :

- A- Un urticaire
- B- Des   pigastralgies
- C- Une hypoguesie
- D- Une constipation
- E- Des arthralgies

29- Les situations    l'origine d'une aggravation de l'ophtalmopathie de Basedow sont :

- A- Le tabagisme
- B- Une corticoth  rapie par voie g  n  rale
- C- Un traitement de l'hyperthyro  die par iode radioactif
- D- Un traitement    base d'iode
- E- Un traitement par carbimazole

30- Les hyperthyro  dies d'origine auto-immune sont :

- A- La thyro  dite d'Hashimoto
- B- La mutation activatrice du r  cepteur de la TSH
- C- Le goitre multinodulaire toxique
- D- Le traitement par interf  ron
- E- La maladie de Basedow

31- Le passage transplacentaire concerne :

- A- La FT3
- B- La TSH
- C- Les anti-thyro  diens de synth  se
- D- La FT4
- E- Les anticorps anti-r  cepteur de TSH

32- Au cours d'une hyperthyro  die durant la grossesse, les anticorps anti-r  cepteur de TSH :

- A- Passent la barri  re placentaire
- B- Peuvent cr  er une hypothyro  die f  tale et n  onatale
- C- Doivent   tre recherch  s dans la maladie de Basedow trait  e avant la grossesse par IRA
- D- Doivent   tre recherch  s dans la maladie de Basedow trait  e avant la grossesse par chirurgie
- E- Positifs n  cessitent une surveillance   chographique de la thyro  de f  tale

33-Le passage transplacentaire des antithyro  diens de synth  se peut cr  er chez le f  tus:

- A- Une ectopie thyro  dienne
- B- Des nodules thyro  diens
- C- Une hypothyro  die
- D- Une thyro  dite auto-immune
- E- Un goitre

34-Le traitement radical en cas de l'hyperthyro  die est indiqu   en cas de :

- A- Cardiothyro  se
- B- Thyrotoxicose factice
- C- Thyro  dite de De-quervain
- D- Maladie de Basedow r  cidivante
- E- Goitre multinodulaire toxique

35-Le traitement par iode radioactif en cas d'hyperthyro  die :

- A- Doit   tre pr  c  d   d'une stabilisation de l'hyperthyro  die
- B- Peut entra  ner une hypothyro  die secondaire
- C- Est contre indiqu   chez le sujet   g  
- D- Est contre-indiqu   en cas de grossesse
- E- Est indiqu   en cas de maladie de Basedow avec goitre de grande taille

36-Les facteurs aggravant une orbitopathie basedowienne sont:

- A- La freination de TSH
- B- Le tabac
- C- Le traitement par iode radioactif
- D- La corticoth  rapie
- E- Une hypothyro  die secondaire aux anti-thyro  diens de synth  se

37-Le traitement par iode radioactif de l'hyperthyro  die :

- A- N  cessite l'arr  t pr  alable des antithyro  diens de synth  se
- B- A un effet imm  diat sur l'hyperthyro  die
- C- Est contre indiqu   chez la femme enceinte
- D- N  cessite au pr  alable une pr  paration par le lugol
- E- Est le traitement de choix des thyro  dites subaigu  s

Cas clinique n  1 :

- Mme M   g  e de 26 ans, tabagique, adress  e par son m  decin pour hyperthyro  die. Sa s  ur est suivie pour thyro  dite de Hashimoto. La patiente rapporte des palpitations et un amaigrissement r  cent.
- A l'examen: goitre homog  ne visible    distance et une exophtalmie avec un   d  me palp  bral bilat  ral.
- A l'ECG: tachycardie sinusale    120 batt/min.
- TSH= 0,01 mUI/l et FT4= 88 pmol/l
- La patiente a   t   mise sous Thiamazole : 20 mg/j.

1- Les arguments cliniques en faveur de l'origine Basedowienne de cette hyperthyro  die sont :

- A- L'ant  c  dent familial de thyro  dite d'Hashimoto chez la s  ur
- B- La tachycardie    120 b/min
- C- L'amaigrissement
- D- Le goitre homog  ne
- E- L'exophtalmie avec un   d  me palp  bral bilat  ral

2- Parmi les facteurs qui peuvent aggraver l'atteinte oculaire de cette patiente, vous retenir :

- A- Le tabagisme
- B- L'  ventuel traitement radical par iode radioactif devant une r  cidive apr  s euthyro  die
- C- Le taux de FT4 sup  rieur    3 fois la normale
- D- Le traitement par Thiamazole
- E- L'  ventuel passage en hypothyro  die sous thiamazole

3- Le traitement par thiamazole chez cette patiente :

- A- Agit sur la synth  se des hormones thyro  diennes
- B- Donne un effet apr  s un d  lai de 2 jours
- C- N  cessite la surveillance de la NFS
- D- Est contre-indiqu   en association aux b  tabloquants
- E- Doit   tre maintenu    vie

Cas clinique n  2:

Patiente M   g  e de 28 ans, a 2 enfants de 2 et 5 ans, vous consulte pour asth  nie au moindre effort, un amaigrissement de 5 kg en 1 mois, am  norrh  e depuis 3 mois.

On note un tabagisme actif    30 PA.

Cliniquement, son poids est de 48Kg pour 1m65, sa tension art  rielle est    110/70 mmHg, et sa T   est    36,5  C.

Elle pr  sente une polypn  e, une tachycardie    120/min, un tremblement fin des extr  mit  s et un go  tre homog  ne    la palpation avec Thrill.

Une exophtalmie bilat  rale et sym  trique, une r  traction des paupi  res sup  rieures. Rythme cardiaque r  gulier sinusal. Il n  existe pas de signes d  insuffisance cardiaque.

Vous recevez un bilan thyro  dien r  alis   par son m  decin traitant deux jours auparavant :

T4libre : 70 pmol/L (9-22), TSH< 0,001 mUI/L (0,4 et 4 mUI/L).

1- Le diagnostic de maladie de basedow est   voqu  e devant:

- A- Une exophtalmie bilat  rale et sym  trique
- B- Une r  traction de paupi  res sup  rieures
- C- Un Goitre vasculaire
- D- Un tremblement des extr  mit  s
- E- Un thrill    la palpation de la thyro  de

2- Les r  sultats d  explorations attendues chez cette patiente sont:

- A- Une   chographie cervicale objectivant un goitre vasculaire
- B- Une fixation en damier    la scintigraphie thyro  dienne
- C- Des TRAK positifs
- D- Des anticorps anti-Thyrop  roxydase n  gatifs
- E- Des anticorps anti-Thyroglobuline n  gatifs

3- La prise en charge th  rapeutique de premi  re intention pour cette patiente comporte :

- A- Une contraception efficace
- B- B  ta-Bloquants
- C- Repos
- D- Propylthiouracyl lors de l  initiation
- E- Carbimazole

- 4- La patiente consulte les urgences, 20 jours apr  s avoir commencer le traitement prescrit,    l'examen: T 39  C, tachycarde, odynophagie, asth  nie, gorge rouge.
La radiographie du thorax normal, CRP n  gative.

Le diagnostic   voquer en 1  r lieu est :

- A- Une h  patite virale
- B- Une surinfection suite au traitement d'hyperthyro  die
- C- Une atteinte h  patique iatrog  ne
- D- Un lymphome
- E- Une agranulocytose

- 5- **Le 1  r examen compl  mentaire    demander en urgence est :**

- A- Bilan h  patique
- B- NFS
- C- Procalcitonine
- D- LDH
- E- Pr  l  vement oro-pharyng  

- 6- Le bilan a r  v  l   une Procalcitonine n  gative, LDH normale, bilan h  patique normal et    la NFS : PNN <500/mm³

Cette situation clinique est :

- A- D'origine imm  uno-allergique
- B- Secondaire aux anti-thyro  diens de synth  se
- C- Fr  quente chez la femme
- D- Grave
- E- Une complication iatrog  ne